

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ CML・骨髄腫の経口薬の服用時点(空腹時等)と残薬の管理
- ☐ 抗ウイルス薬・ST合剤・抗血栓薬など予防投与の継続確認
- ☐ 市販の胃薬・サプリ・グレープフルーツの確認
- ☐ 電話フォローで発熱・むくみ・息切れ・足の腫れを確認
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ 病型・レジメンの監査、HBV検査と予防投与の計画
- ☐ アントラサイクリン累積量・前投薬・腫瘍崩壊症候群対策
- ☐ CAR-T・二重特異性抗体のCRS/ICANSへの院内対応
- ☐ レナリドミド等の適正管理手順(RevMate)の運用
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与歴の記載

病院と共有する情報

病型・レジメン・投与歴

検査値

副作用のGrade

予防投与の服用状況

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

レジメン・薬剤	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
R-CHOP	リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(1日目)+プレドニゾロン(1~5日目内服)	3週毎	B型肝炎検査、プレドニゾロンの服用日・高血糖、ビンクリスチンの便秘、心毒性
イマチニブ	400mg 1日1回 食後 連日内服	連日	浮腫・体重増加、筋けいれん、CYP3A4相互作用
ダサチニブ ニロチニブ	ダサチニブ 1日1回/ニロチニブ 1日2回(空腹時:食事の1時間以上前または食後2時間以降)	連日	胸水(ダサチニブ)、QT延長・高血糖(ニロチニブ)、胃酸分泌抑制薬の併用
レナリドミド +デキサメタゾン	レナリドミド 1~21日目内服+デキサメタゾン週1回(±ダラツムマブ)	4週毎	適正管理手順(RevMate)・避妊・血栓予防薬、腎機能で用量調整
ボルテゾミブ	皮下注 週1~2回(レジメンにより異なる)	3~5週毎	末梢神経障害、带状疱疹予防(アシクロビル等)、起立性低血圧

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	レナリドミド・ボマリドミド 催奇形性	既往・疾患 妊娠・妊娠の可能性	胎児への重篤な影響	RevMateの手順と避妊の継続を確認
注意	ダサチニブ・ニロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓→効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意	イマチニブ・ニロチニブ等 CYP3A4阻害	処方薬 サプリ・食品 アゾール系抗真菌薬・グレープフルーツ	血中濃度↑→副作用↑	他院の抗真菌薬・食品の摂取を確認
注意	ニロチニブ QT延長の重複	処方薬 抗不整脈薬・マクロライド系等	QT延長・不整脈	併用薬と低K・低Mg血症の有無を確認
注意	抗CD20抗体 免疫抑制	既往・疾患 HBs抗原陽性・Hbc抗体陽性	B型肝炎の再活性化	HBV-DNAのモニタリング予定を確認
確認	ダラツムマブ 検査への干渉	処置・検査 他院での輸血(輸血前検査)	交差適合試験が偽陽性	他院受診時に投与歴を伝えるよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「B型肝炎の検査結果を確認させていただきます。治療中や治療後にウイルスが再び増えることがあります」

確認:お薬手帳で病型・レジメン・HBV検査の結果、併用薬(CYP3A4・胃薬)

△ HBV-DNAの定期測定の前定を確認

投与当日~1週

「点滴中や当日の夜に、寒気・発熱・発疹が出る場合があります。我慢せずすぐに伝えてください」

確認:前投薬の服用、CAR-T後の連絡先と治療施設の把握

△ CAR-T後は発熱・意識の変化で至急連絡、運転は控える

投与後1~2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローで発熱、带状疱疹予防薬・ST合剤の服用を確認

△ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

長期服用中

「毎日の服用が効果を保つ鍵です。むくみや息苦しさ、足の腫れなど気になる変化はありませんか」

確認:TKIの服薬継続・残薬、むくみ・息切れ・足の腫れ

△ 片足の腫れ・急な息切れは血栓症を疑い至急受診